

MANUAL TÉCNICO Y CLÍNICO: INVENTARIO DE IMPULSIVIDAD DE DICKMAN (DII)

1. FICHA TÉCNICA

- **Nombre del Instrumento:** Inventario de Impulsividad de Dickman (DII - Dickman Impulsivity Inventory).
- **Autor Original:** Scott J. Dickman (1990).
- **Adaptación Española:** Eduardo J. Pedrero Pérez (2009) - Nueva traducción mediante proceso de traducción/retraducción.
- **Constructo Evaluado:** Impulsividad en sus dos dimensiones independientes: Impulsividad Funcional (IF) e Impulsividad Disfuncional (ID).
- **Población Objetivo:** Adultos. Validado tanto en población general (no clínica) como en población clínica (adictos a sustancias en tratamiento).
- **Formato de Respuesta:** Elección forzosa dicotómica (Verdadero / Falso).
- **Tiempo Estimado de Aplicación:** 5 a 10 minutos.

2. PLANTILLA DE CORRECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES

El cuestionario consta de 23 ítems divididos en dos subescalas independientes.

A. Método de Puntuación

La prueba es dicotómica. El cálculo se realiza sumando los puntos obtenidos según el tipo de ítem (Directo o Invertido):

- **Ítems Directos:** Se puntúa **1 punto si la respuesta es "Verdadero"** y 0 puntos si es "Falso".
- **Ítems Invertidos (-):** Se puntúa **1 punto si la respuesta es "Falso"** y 0 puntos si es "Verdadero".

B. Distribución de Ítems por Factor

Factor 1: Impulsividad Disfuncional (ID) - 12 ítems

Puntuación máxima: 12 puntos.

- **Ítems Directos:** 1, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 21. (*Verdadero = 1*)
- **Ítems Invertidos:** 4, 14, 22, 23. (*Falso = 1*)
(*Nota clínica: El artículo señala que los ítems 4 y 23 muestran cierta debilidad psicométrica y dificultad de adscripción factorial, por lo que podrían considerarse para exclusión en futuras revisiones para elevar el alfa de Cronbach, pero para la corrección estándar actual deben contabilizarse.*)

Factor 2: Impulsividad Funcional (IF) - 11 ítems

Puntuación máxima: 11 puntos.

- **Ítems Directos:** 5, 6, 15, 16, 19, 20. (*Verdadero = 1*)
- **Ítems Invertidos:** 2, 3, 8, 11, 12. (*Falso = 1*)

Cálculo final: Sumar los puntos obtenidos en los ítems correspondientes a cada escala para obtener la Puntuación Directa (PD) de ID y la PD de IF.

3. PAUTAS DE INTERPRETACIÓN PARA EL REPORTE PSICOLÓGICO

A diferencia de los instrumentos clásicos que conceptualizan la impulsividad únicamente como un rasgo patológico, el modelo de Dickman exige que el clínico redacte el informe interpretando **dos perfiles independientes**.

Perfil 1: Impulsividad Disfuncional (ID)

Refleja la tendencia a tomar decisiones irreflexivas, rápidas y sin precisión en situaciones donde esta estrategia no es óptima, trayendo consecuencias negativas para el individuo.

- **Puntuaciones Altas:**

- **En el reporte:** Describir al evaluado con una marcada tendencia a la falta de previsión, ausencia de premeditación y baja deliberación. El sujeto es propenso a actuar sin medir las consecuencias.
- **Implicaciones Clínicas:** Altamente correlacionado con el abuso y adicción a sustancias (heroína, cocaína, alcohol). Fuerte vinculación con **sintomatología disejecutiva frontal** (dificultades inhibitorias, problemas de atención, fallos en la memoria de trabajo).
- **Rasgos asociados:** Búsqueda de novedad (extravagancia, desorden), propensión al fracaso escolar, conducción temeraria, ira, conducta agresiva y sintomatología depresiva. En pacientes en tratamiento (ej. ludopatía o adicciones), predice peores resultados terapéuticos.

Perfil 2: Impulsividad Funcional (IF)

Refleja la tendencia a tomar decisiones rápidas cuando la situación implica un beneficio personal o exige celeridad. Supone un proceso de "toma de decisiones con riesgo calculado".

- **Puntuaciones Altas:**

- **En el reporte:** Describir al sujeto como alguien capaz de procesar información de forma acelerada, enérgico (drive), y adaptable ante oportunidades inesperadas. No vinculable a psicopatología ni a procesos adictivos (los adictos y la población general puntúan igual en esta dimensión).
- **Implicaciones Clínicas:** Se relaciona con la agilidad mental, la capacidad para generar más hipótesis frente a situaciones ambiguas y un mejor rendimiento en tareas que exigen decisiones contra reloj (ej. test de Stroop, Iowa Gambling Task).
- **Rasgos asociados:** Extraversión, búsqueda de sensaciones, aventurerismo, vivacidad, reactividad a la recompensa y excitabilidad exploratoria (curiosidad). Correlaciona *negativamente* con la disfunción ejecutiva, el afecto negativo y el neuroticismo.

Sugerencia de Redacción para el Informe (Ejemplo Práctico):

"Los resultados del Inventario de Dickman muestran que el/la paciente presenta puntuaciones significativamente elevadas en Impulsividad Disfuncional, lo que sugiere un déficit en los mecanismos de inhibición y una fuerte tendencia a la actuación irreflexiva sin evaluación de riesgos, perfil congruente con la vulnerabilidad al mantenimiento de conductas adictivas. Sin embargo, su puntuación conservada/alta en Impulsividad Funcional indica que posee agilidad cognitiva y capacidad de decisión rápida frente a recompensas, habilidades o recursos 'sanos' que podrían canalizarse positivamente en el encuadre psicoterapéutico."